Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 1

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 1

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 1

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition : concepts, modes d'intervention, acteurs et politiques nutritionnelles

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 1

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Santé publique; Promotion de la santé; Politiques nutritionnelles

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ; définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ; distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ; distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle), et les différencier de l'éducation thérapeutique du patient (BC1) ; citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ; identifier les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition, et ceux qui recueillent et produisent des données.

Contenu. 1. Les définitions à savoir par cœur ; 2. Les classifications à ne pas confondre ; 3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 ; 4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) ; 5. Chiffres-clés ; 6. Les pièges classiques ; 7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases ; 8. Auto-test (réponses en bas de page) ; 9. Flashcards à découper ; O1.1 – Qualifier mon action.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ;

■ définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ;

■ distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ;

■ distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pou

■ citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ;

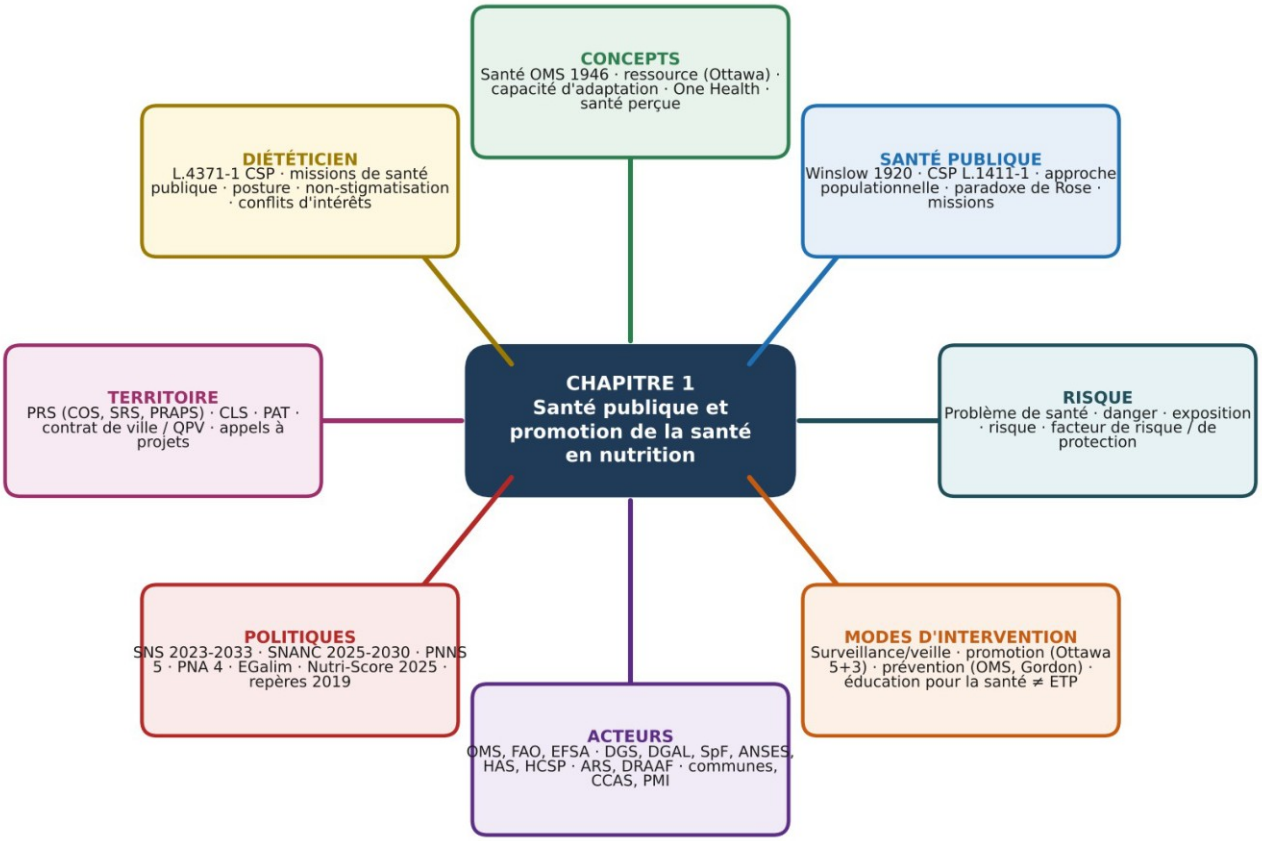
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 1 5
1. Les définitions à savoir par cœur 5
2. Les classifications à ne pas confondre 5
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 6
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 6
5. Chiffres-clés 6
6. Les pièges classiques 6
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 6
8. Auto-test (réponses en bas de page) 6
9. Flashcards à découper 7

Fiches-outils du chapitre 1 7
O1.1 – Qualifier mon action 7
O1.2 – Portrait express de mon territoire 7
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 8
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 8
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 8
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 9
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 9
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 9

Fiche de révision du chapitre 1

Santé publique, promotion de la santé et politiques nutritionnelles



Carte mentale du chapitre 1

1. Les définitions à savoir par cœur

Notion · Définition · Source, date

Santé — *Définition :* « État de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » ; *Source, date :* OMS, Constitution, 1946

Santé (ressource) — *Définition :* « Ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie » ; *Source, date :* Charte d'Ottawa, 1986

One Health — *Définition :* Approche intégrée visant à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ; *Source, date :* OHHLEP / Quadripartite, 2021-2022

Santé publique — *Définition :* Science et art de prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé par les efforts coordonnés de la communauté ; *Source, date :* Winslow, 1920

Promotion de la santé — *Définition :* Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci ; *Source, date :* Charte d'Ottawa, 21/11/1986

Prévention — *Définition :* Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ; *Source, date :* OMS, 1948

Éducation pour la santé — *Définition :* Permettre à chacun d'acquérir les compétences et les moyens de promouvoir sa santé et celle de la collectivité ; *Source, date :* PNES, 2001

Universalisme proportionné — *Définition :* Actions pour tous, d'intensité proportionnelle au désavantage social ; *Source, date :* Marmot, 2010

Danger / risque — *Définition :* Danger = capacité à nuire ; risque = probabilité de l'effet néfaste (danger × exposition) ; *Source, date :* –

2. Les classifications à ne pas confondre

Prévention OMS (moment) · Indicateur visé · Gordon (public) · Exemple

Primaire : avant la maladie — *Indicateur visé :* Incidence ; *Gordon (public) :* Universelle : tous ; *Exemple :* Repères PNNS, atelier cuisine pour tous

Secondaire : début, dépistage — *Indicateur visé :* Prévalence ; *Gordon (public) :* Sélective : groupe à risque ; *Exemple :* Ateliers en QPV ; dépistage de la dénutrition

Tertiaire : maladie installée — *Indicateur visé :* Complications, récidives ; *Gordon (public) :* Indiquée : facteurs de risque présents ; *Exemple :* ETP diabète (BC1) ; programme enfants en surpoids

Quaternaire (Jamoulle) — *Indicateur visé :* Surmédicalisation ; *Gordon (public) :* – ; *Exemple :* Éviter les régimes inutiles

Patients atteints de maladie Déterminants, milieux, Compétences des personnes Un problème de santé défini

chronique, programme déclaré politiques, pouvoir d'agir bien portantes à l'ARS

3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3

- **5 domaines** : politique publique saine – milieux favorables – action communautaire – aptitudes individuelles
- réorientation des services de santé (« **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement »).
- **3 stratégies** : plaider – conférer les moyens – servir de médiateur.

4. Les dates et textes à jour (octobre 2026)

Date · Texte
1946 / 1948 — *Texte :* Constitution de l'OMS (signée / entrée en vigueur)
1986 — *Texte :* Charte d'Ottawa
2001 — *Texte :* PNNS 1
2004 — *Texte :* Loi relative à la politique de santé publique (PNNS dans la loi, distributeurs interdits à l'école)
2009 — *Texte :* Loi HPST (ARS, ETP)
2014 — *Texte :* Loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
2016 — *Texte :* Loi de modernisation de notre système de santé (Nutri-Score, 2017)
2018 — *Texte :* Loi EGalim (50 % durables et de qualité dont 20 % bio)
2019 — *Texte :* Repères alimentaires Santé publique France ; PNNS 4 (2019-2023)
2021 — *Texte :* Loi Climat et résilience (art. 265 : SNANC)
14/03/2025 — *Texte :* Nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté)
Juin 2025 — *Texte :* Avis du HCSP pour le PNNS 5 ; lancement de l'enquête Albane
11/02/2026 — *Texte :* SNANC 2025-2030 publiée
08/04/2026 — *Texte :* PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés (One Health Summit, Lyon)

5. Chiffres-clés

- Obésité de l'adulte : **18,1 %** (OFÉO 2024) ; 22,4 % outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques.
- Surpoids des 6-17 ans : **17 %** dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015).
- Précarité alimentaire : **16 %** (Crédoc 2022).
- 5 fruits et légumes/jour : **30 %** des adultes, 20 % des enfants ; fibres < 25 g/j : 90 % des adultes (HCSP 2025).
- Espérance de vie 2025 : **85,9 ans** (F), **80,3 ans** (H) ; écart de ≈ 13 ans entre hommes aisés et modestes.
- PNNS 5 : **3 axes, 20 mesures**, – 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents (– 20 % chez les plus défavorisés).
- EGalim (achats 2023) : ≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio.

6. Les pièges classiques

Attention

- Citer le **PNNS 4** comme en vigueur → c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**.
- Dire que le **Nutri-Score est obligatoire** → il est **facultatif**.
- Classer le **dépistage** en prévention primaire → **secondaire**.
- Appeler « éducation pour la santé » un atelier destiné à des **patients** d'un programme d'ETP → c'est de l'**ETP** (BC1).
- Confondre **incidence** (nouveaux cas) et **prévalence** (cas existants).
- Comparer des chiffres issus de **méthodes différentes** (mesuré / déclaré).
- Oublier les **déterminants** et proposer uniquement de l'information.

7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases

1. Mode d'intervention : « Mon projet est une action d'éducation pour la santé (alimentaire/nutritionnelle/sensorielle)… »

2. Prévention : « … au service de la prévention primaire, sélective, car le public… »

3. Promotion de la santé : « Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé car… (participation, milieu favorable, partenariat). »

4. Politiques : « Il répond à l'axe … du PNNS 5 (2026-2030), à l'objectif … du PRS et à la fiche-action … du CLS. »

8. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Qui a défini la santé publique en 1920 ?

2. Quels sont les 5 domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?

3. Quel niveau de prévention fait baisser l'incidence ?

4. Quelle classification distingue universelle, sélective et indiquée ?

5. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand a-t-elle été publiée ?

6. Combien d'axes et d'actions compte le PNNS 5 ?

7. Quels sont les deux seuils EGalim en restauration collective ?

8. Quel organisme conduit les études INCA ? Et ESTEBAN ?

9. Que contient un PRS ?

10. Calculez le coût par portion d'une recette de 9,60 € pour 12 portions.

11. Une diététicienne anime un atelier pour des patients d'un programme ETP diabète : de quoi s'agit-il ?

12. Donnez la formule du taux d'atteinte d'un indicateur. *Réponses : 1. Winslow – 2. Politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services – 3. Primaire – 4. Gordon (1983) – 5. Loi Climat et résilience (art. 265) ; 11 février 2026 – 6. 3 axes, 20 mesures – 7. 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio (et 60 % pour viandes et poissons) – 8. ANSES ; Santé publique France – 9. COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS – 10. 9,60 / 12 = 0,80 €*

– – *11. ETP, prévention tertiaire (BC1) – 12. Réalisé / prévu × 100.*

9. Flashcards à découper

Recto : Charte d'Ottawa – date et 3 stratégies ? · Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur

Recto : Prévalence ou incidence : laquelle baisse avec la prévention primaire ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : L'incidence (nouveaux cas)

Recto : Universalisme proportionné : auteur, date, principe ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : Marmot, 2010 ; pour tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage

Recto : PNNS en vigueur et son objectif enfant ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : PNNS 5 (2026-2030) ; − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents

Recto : Que signifie SMART ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel

Recto : Rôle de l'ARS en prévention ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : PRS, financement (FIR), appels à projets, CLS, déclaration des programmes d'ETP

Recto : Paradoxe de Rose ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : Beaucoup de personnes à faible risque produisent plus de cas que peu de personnes à haut risque

Recto : Les 3 formes d'éducation pour la santé du guide BTS ? — *Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur :* Verso : Nutritionnelle, alimentaire, sensorielle

Fiches-outils du chapitre 1

Ces 8 outils complètent les fiches F1 à F14 pour les notions propres au chapitre 1. Ils sont vierges, à imprimer ou à remplir dans Word, et servent en stage (période 1 surtout), en préparation du dossier E5 et en révision.

Outil · Intitulé · Utilité

O1.1 — *Intitulé :* Qualifier mon action ; *Utilité :* Nommer précisément le mode d'intervention et le niveau de prévention (oral E5)

O1.2 — *Intitulé :* Portrait express de mon territoire ; *Utilité :* Collecter les données de base du diagnostic (F1)

O1.3 — *Intitulé :* Carte des acteurs de mon territoire ; *Utilité :* Identifier partenaires, financeurs, ressources

O1.4 — *Intitulé :* Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur ; *Utilité :* Rédiger la partie « contexte » du dossier

O1.5 — *Intitulé :* Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa ; *Utilité :* Vérifier que le projet ne se limite pas à l'information

O1.6 — *Intitulé :* Les déterminants de l'alimentation de mon public ; *Utilité :* Appliquer le modèle de Dahlgren et Whitehead

O1.7 — *Intitulé :* Tableau de veille des politiques nutritionnelles ; *Utilité :* Tenir à jour les versions des textes (C3.4)

O1.8 — *Intitulé :* Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ; *Utilité :* Contrôler un support avant diffusion

O1.1 – Qualifier mon action

Intitulé de l'action

Public (qui, combien, caractéristiques)

Problème de santé visé

Question	☐	Justification
Mode : surveillance / veille sanitaire	☐	
Mode : promotion de la santé (agit sur déterminants, milieux, politiques, pouvoir d'agir)	☐	
Mode : prévention (problème défini)	☐	
Mode : éducation pour la santé – nutritionnelle	☐	
Mode : éducation pour la santé – alimentaire	☐	
Mode : éducation pour la santé – sensorielle	☐	
Attention : s'agit-il d'ETP (patients, programme déclaré à l'ARS) ? → BC1	☐	
OMS : primaire (incidence)	☐	
OMS : secondaire (dépistage, prévalence)	☐	
OMS : tertiaire (complications)	☐	
OMS : quaternaire (surmédicalisation)	☐	
Gordon : universelle	☐	
Gordon : sélective	☐	
Gordon : indiquée	☐	
Approche : informative / persuasive / participative	☐	
Universalisme proportionné appliqué ?	☐	

Ma phrase de qualification pour l'oral (4 phrases : mode, prévention, promotion, politiques)

O1.2 – Portrait express de mon territoire

Consigne

Pour chaque indicateur, notez la valeur pour votre territoire et une valeur de comparaison (département, région ou France), avec la source et l'année. Sources utiles : Insee (statistiques locales), Géodes (Santé publique France), ORS (Score-santé), ARS (diagnostic du PRS, CLS), *sig.ville.gouv.fr* (QPV), Drees.

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Population totale				
Part des moins de 20 ans / des 65 ans et plus				
Familles monoparentales (%)				
Taux de pauvreté (%)				
Taux de chômage (%)				

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Quartier prioritaire (oui/non, nom)				
Espérance de vie / mortalité prématurée				
Surpoids, obésité (enfants, adultes)				
Diabète traité, maladies cardiovasculaires (ALD)				
Offre alimentaire (commerces, marché, restauration rapide)				
Restauration scolaire (tarification, EGalim)				
Aide alimentaire (épicerie, banque alimentaire)				
Équipements sportifs, espaces verts				
Professionnels de santé (MSP, diététiciens, PMI)				

Trois constats principaux

01.3 – Carte des acteurs de mon territoire

Niveau	Acteur (nom exact)	Rôle / missions	Intérêt pour mon projet (données, partenaire, financeur, relais)	Contact (fonction, mail professionnel)
National				
Régional (ARS, DRAAF, Promotion Santé, ORS)				
Départemental (PMI, action sociale)				
Commune / intercommunalité (CCAS, CLS, PAT, politique de la ville)				
Éducation (écoles, collèges, santé scolaire)				
Santé de proximité (MSP, CPTS, médecins)				
Social (centres sociaux, CAF)				
Associations (aide alimentaire, sport, culture, patients)				
Économiques (commerces, marché, producteurs, entreprises)				
Habitants / usagers (groupes, conseils citoyens)				

01.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur

Consigne

Vérifiez la **version en vigueur** de chaque texte le jour de la rédaction (fiche 01.7). Citez l'axe, l'action ou l'objectif précis, avec la date.

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
Stratégie nationale de santé		
SNANC 2025-2030		
PNNS 5 (2026-2030)		
PNA 4 (2026-2030)		
Lois (EGalim, Climat et résilience…)		
PRS de ma région (SRS, PRAPS)		
Contrat local de santé		
Projet alimentaire territorial		
Contrat de ville / QPV		
Projet de la structure d'accueil		

Rédaction du paragraphe « contexte » (5 à 8 lignes)

01.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa

1. Élaborer une politique publique saine

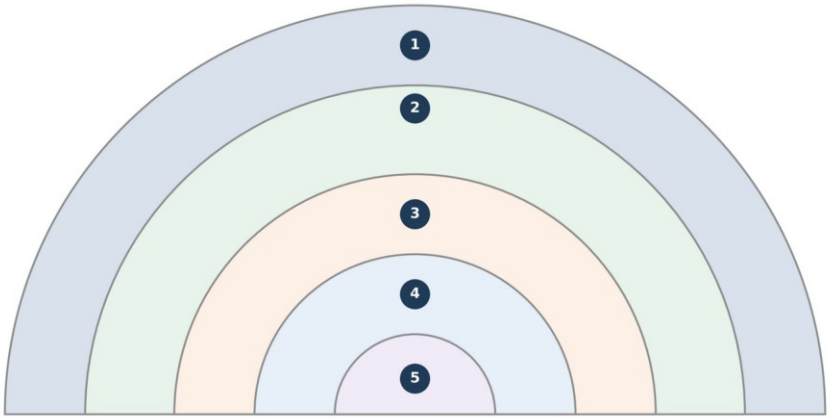
2. Créer des milieux favorables

3. Renforcer l'action communautaire

4. Acquérir des aptitudes individuelles

5. Réorienter les services de santé

O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public



Modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) – à légender

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
1. Âge, sexe, hérédité		
2. Style de vie personnel		
3. Réseaux sociaux et communautaires		
4. Conditions de vie et de travail		
5. Conditions socio-économiques, culturelles, environnementales		

O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles

Texte	Version vérifiée	Date de vérification	Statut (en vigueur, en révision, abrogé)	Source (lien) et changement repéré
SNANC	2025-2030 (11/02/2026)	05/10/2026	En vigueur	ecologie.gouv.fr
PNNS	PNNS 5 2026-2030 (08/04/2026)	05/10/2026	En vigueur	sante.gouv.fr ; mangerbouger.fr
PNA	PNA 4 2026-2030	05/10/2026	En vigueur	agriculture.gouv.fr
Repères alimentaires adultes	Santé publique France, 2019	05/10/2026	En vigueur, révision annoncée	mangerbouger.fr
Nutri-Score	Arrêté du 14/03/2025	05/10/2026	En vigueur (transition 2 ans)	sante.fr
EGalim, bilan « ma cantine »				
PRS de ma région				

O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support

Critère	Oui / Non	Correction à apporter
Le message est positif et valorise ce que les personnes peuvent faire		
Il évite les mots culpabilisants (« mauvais aliments », « il faut », « interdit »)		
Il n'associe pas poids et valeur de la personne ; pas d'images dégradantes		
Il tient compte des contraintes (budget, temps, équipement)		
Il respecte les cultures et les pratiques religieuses		
Il est lisible (littératie : phrases courtes, pictogrammes, police ≥ 12 pt)		
Il est traduit ou accompagné oralement si nécessaire		
Les informations sont validées, datées et sourcées (repères officiels)		
Aucune marque n'est promue ; pas de conflit d'intérêts		
Les images de personnes ont une autorisation écrite (droit à l'image)		
Aucune donnée personnelle ou de santé n'apparaît		
Le support a été testé auprès de quelques personnes du public		